

CAT devant un accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques

Charaoui Khalida

Définition des AES

- Tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang survenant à la suite d'une effraction cutanée (piqûre, coupure) ou d'une projection sur une muqueuse (œil, bouche) ou sur une peau lésée.
- Sont également considérés comme AES, les accidents similaires impliquant des liquides biologiques tels que le LCR, le liquide pleural ou les sécrétions génitales (AELB)

Risque de transmission du VIH

- Taux de séroconversion après une exposition percutanée = **0,3%**
- Facteurs augmentant le risque = profondeur de la blessure, le calibre de l'aiguille et présence de sang frais dans l'aiguille
- Facteurs diminuant le risque = port de gants et charge virale indétectable chez le patient source
- Le traitement ARV dans les suites immédiates diminue le risque de séroconversion pour le VIH

Risque de transmission du VHB

- Taux de transmission après exposition percutanée chez un sujet non vacciné 2 à **40%**
- **Vaccination obligatoire des professionnels de santé +++**

Risque de transmission du VHC

- Taux de transmission après exposition percutanée **< 3%**
- Pas de vaccin et pas de traitement prophylactique post-exposition

Risque de transmission

Virus	Exposition percutanée	Contact muqueux ou peau lésée
VIH	0,32%	0,04%
VHB	2 à 40% (fonction du taux de répllication et de l'exposition)	Non quantifié Risque probablement élevé
VHC	1-3%	Non quantifié Non documenté mais plausible

Facteurs prédictifs de la transmission du VIH après exposition percutanée

Facteur de risque	Risque relatif
Blessure profonde (IM)	16%
Sang visible sur instrument blessant	5%
Aiguille creuse utilisée en IV ou intra-artériel direct	5%
Patient source au stade terminal de SIDA	6%

Conduite à tenir en cas d'AES = urgence médicale = protocole strict

Soins immédiats : nettoyage de la plaie +++

Blessure ou piquêre

Ne pas faire saigner

Nettoyage immédiat à l'eau courante et au savon (ne pas utiliser une solution hydro-alcoolique)

Rinçage

Antisepsie (5minutes au moins de trempage) avec :

Eau de javel 12° diluée au 1/10^{ème}

À défaut : alcool 70° ou polyvidone iodée

Si trempage impossible, appliquer un pansement imbibée de solution antiseptique

Projection muqueuse (conjonctive...)

Rinçage immédiat abondant à l'eau courante ou au sérum physiologique au moins 10 minutes puis appliquer une solution antiseptique (collyre pour les yeux à répéter 10 min après, si port de verres de contact il faut les jeter)

Consultation ophtalmo recommandée

Évaluation du risque de transmission

Avis médical urgent +++
(2 à 4 heures)

Médecine du travail
Infectiologue référent
Ou autre médecin pour
évaluation du risque

Déterminer :

- L'heure de la blessure
- L'acte pratiqué
- Le liquide biologique
- La profondeur de la blessure
- Type de matériel en cause
- Protection ou non au moment de l'AES
- Statut sérologique de la personne source et de la victime

- **Risque élevé si aiguille à prélèvement veineux ou artériel contenant du sang**
- **Risque moindre** si aiguille pour injection SC ou IM ou aiguille pleine (suture) ou piqûre au travers de gants
- **Risque moindre** si projection cutanéomuqueuse

Évaluation du risque de transmission

- **Faire les sérologies du VIH (anticorps anti-VIH1/2), VHB (AgHBs, anti-HBc, Anti-HBs) et VHC (anticorps anti-VHC)**
- **Chez le sujet exposé dans les 8 jours post-exposition**
- **Chez le sujet source, en urgence si statut sérologique inconnu**

Statut sérologique du patient source

- Primordial
- Si AgHbs positif: faire une charge virale
- Si VIH positif: faire une charge virale, préciser les traitements antérieurs et en cours
- Si sérologie VHC positive: faire une charge virale
- Si statut sérologique inconnu, faire en urgence et après accord du sujet source, les sérologies VIH, VHB et VHC

Décision de traitement post-exposition (TPE) concernant le VIH

- En urgence
- **Dans les 4 heures suivant l'AES (dans la mesure du possible), au-delà de 72 heures aucun intérêt**
- Par le médecin référent VIH
- Informer la personne victime des risques infectieux, les modalités de la TPE, les incertitudes sur l'efficacité, et les effets secondaires du traitement
- Avoir son consentement éclairé
- Préservatif jusqu'à l'obtention du premier résultat du suivi virologique (6 semaines après l'AES ou 6 semaines et à 3 mois si TPE prescrite)
- Abstention de don de sang pendant 3 mois

Indication de mise en route d'un TPE

Risque et nature de l'exposition	Statut VIH de la personne source		
	Positif		Inconnu
Important : piqûre profonde, aiguille creuse et intravasculaire (artériel ou veineux) Intermédiaire : coupure avec bistouri, piqûre avec aiguille IM ou SC, aiguille pleine, exposition cutanéomuqueuse, (avec temps de contact plus de 15 minutes) Faible : piqûres avec seringues abandonnées, morsures ou griffures, crachats ...	CV détectable TPE	CV 50 copies/ml Pas de TPE	TPE
	TPE	Pas de TPE	Pas de TPE
	Pas de TPE	Pas de TPE	Pas de TPE

Évaluation de la TPE

- TPE= trithérapie antirétrovirale
- Tenofovir/Emtricitabine/Dolutegravir ou
- Tenofovir/Lamivudine/ Dolutegravir
- Réévaluation 2 à 4 jours par un infectiologue référent
- Si risque infectieux non confirmé arrêt du TPE
- Si risque infectieux confirmé, TPE 28 jours

Décision de prophylaxie concernant le VHB

- Vaccination des personnels soignants et de laboratoire (vaccination obligatoire contre l'hépatite B /arrêté du 25 avril 2000)
- Risque de transmission du VHB au cours d'un AES est nul chez les répondeurs à la vaccination
- L'efficacité de la vaccination doit être affirmée au moins une fois par le dosage du taux des anticorps anti-HBS

Traitement post-exposition au VHB

- Indiqué si sujet source est AgHbs + ou statut inconnu
- **Si le sujet exposé est immunisé** (vacciné ou préalablement infecté et guéri avec un taux d'Ac anti-HBs $>10\text{UI/L}$, le risque est nul, aucun traitement et aucun suivi n'est nécessaire
- **Si le sujet exposé n'est pas immunisé** (non vacciné, vaccination incomplète, vacciné mais non répondeur à la vaccination avec taux d'Ac anti-HBs $< 10\text{UI/L}$, absence d'antécédent d'hépatite B) le TPE est indiqué

Traitement post-exposition au VHB

Sérovaccination

- 500 UI d'immunoglobulines spécifiques anti-HBs + une dose de vaccin anti hépatite B en même temps dans deux sites différents dans les 72 heures post-exposition
- Surveillance médicale car risque de réaction d'hypersensibilité
- Poursuivre la vaccination anti hépatite B selon les schémas suivants
- ✓ Schéma 1: J0-M1-M6 (schéma classique)
- ✓ Schéma 2: J0-J7-J21. Rappel M6 (schéma accéléré dans le cas où une protection vaccinale doit être obtenue rapidement)

Traitement antiviral

- ✓ Inhibiteurs de l'ADN polymérase (Tenofovir) efficace pour la prévention de l'hépatite B
- ✓ Co-infection VIH/VHB chez la personne source

Indication de la sérovaccination après exposition professionnelle au VHB

	Statut VHB(AgHBs) personne source	
	Positif	Inconnu
Personne exposée Vacciné répondeur (Ac antiHBs > 10mUI/mL dans les antécédents)	Rien	Rien
Vacciné non répondeur (Ac antiHBs < 10mUI/ML sans anti HBc ni notion d' Ac antiHBs > 100mUI/mL dans le passé)	Immunoglobulines	Rien
Non vacciné	Immunoglobulines + vaccin	Vaccin

Décision de prophylaxie concernant le VHC

- Il n'existe pas de traitement prophylactique vis-à-vis du risque VHC
- La prise en charge rapide d'une éventuelle infection aigue post-exposition est recommandée
- Un suivi clinico-biologique est nécessaire

Suivi clinique et biologique

- Si traitement → suivi par le médecin référent
- Si accident de travail → suivi aussi au service de médecine du travail
- Examen clinique et biologique réalisés avant la prescription initiale et répétés 12 semaines après (rechercher les signes de primo-infection VIH)
- Si sérologie négative confirmée chez le sujet source, arrêter le traitement et la surveillance

Suivi biologique de la personne exposée aux VIH, VHB et VHC

J1	Sérologie VIH
J7	Sérologie VHC Ac Anti-HBs si vacciné et titre Ac inconnu Ou AgHBs, Anti-HBc et Ac Anti-HBs si non vacciné ALAT Créatinine, test de grossesse si indication de TPE
S2	ALAT, créatinine si TPE, comorbidités et crainte de iatrogénie
S6	Sérologie VIH ALAT et sérologie VHC (ARN VHC si ARN VHC + chez sujet source)
S12	Sérologie VIH Sérologie VHC AgHBs, Anti-HBc et Anti-HBs si absence d'immunité de la personne exposée et sujet source AgHBs + ou de statut inconnu

Prise en charge médico-légale

- Déclaration de l'accident de travail dans les 24 heures suivant l'AES
- Enregistrement de l'AES dans un registre paraphé
- Déclaration par l'employeur à l'organisme de sécurité sociale dans les 48 heures ouvrables
- Établissement d'un certificat médical initial